

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Rapport d'Analyse Respiratoire et Oxymétrique

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

☎ 0796 222 597 / 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS DU PATIENT

Nom : Laarafa Habib

ID Patient : 20260915-136

Genre : Masculin

Période enreg. : 23 :33 :00 – 08 :17 :30

Âge : 49 ans

Durée totale : 524,5 min (8h 45min)

Taille / Poids : 171 cm / 81 kg

Durée valide : 524,5 min (100,0%)

IMC : 27,7 kg/m²

Date d'examen : 15 Septembre 2026



Scanner pour accéder au tracé complet et dossier numérique

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE POLYGRAPHIQUE

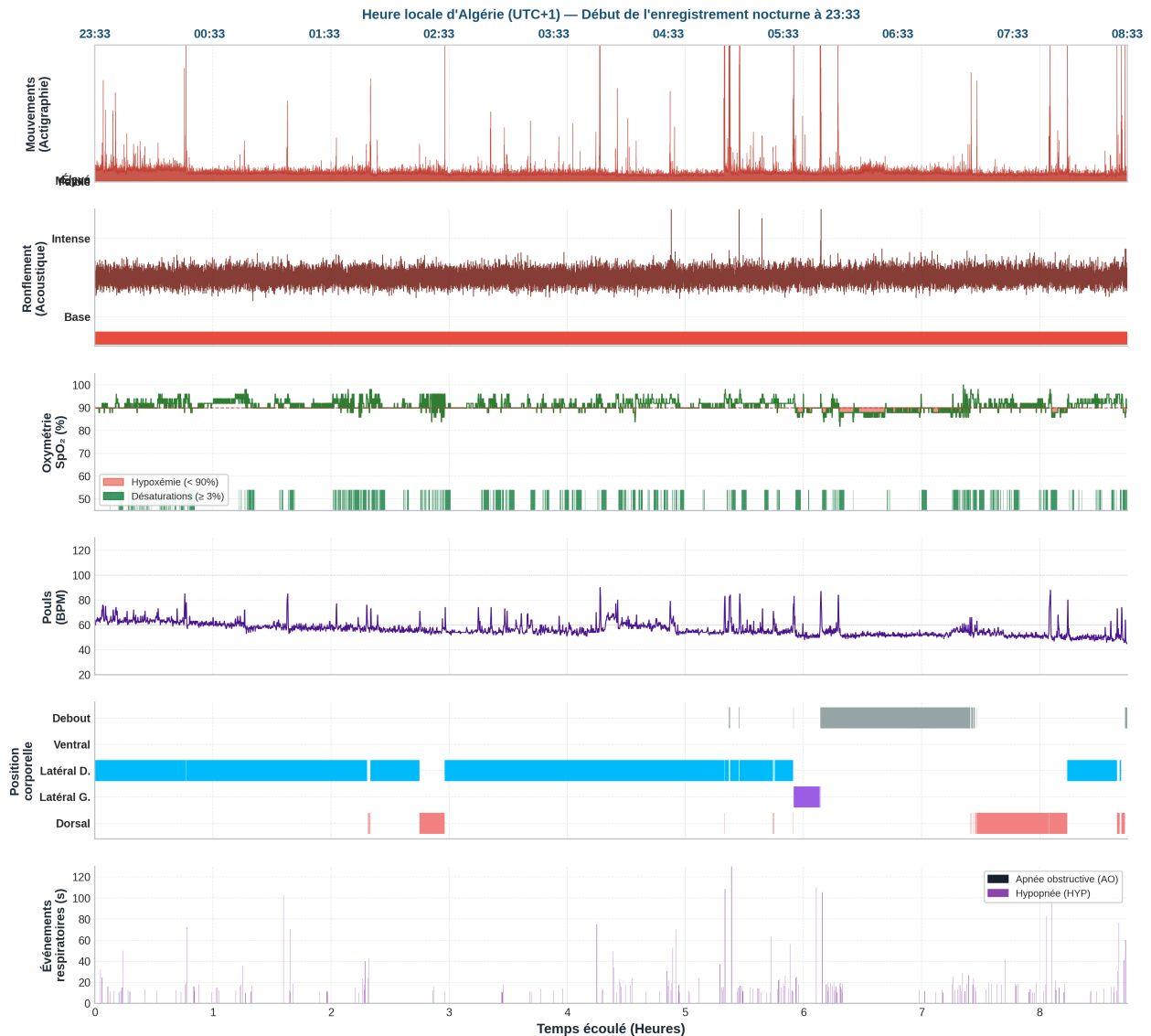


FIGURE 1 – **Enregistrement continu multicanal (23 :33 – 08 :17)** : Variations de pression, débit nasal, oxymétrie de pouls (SpO_2), fréquence du pouls, encodage des positions corporelles et distribution temporelle des événements respiratoires.

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

2.1. DISTRIBUTION POSTURALE ET IMPACT VENTILATOIRE

TABLE 1 – Événements respiratoires et désaturations selon la position corporelle

Position	Durée (min)	%	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO	Total Resp.
								(/h)	
Dorsale (SUP)	65,6	12,5%	2	0	0	0	22	20,1	2
Ventrale (PRO)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Côté gauche (LAT-G)	13,4	2,6%	0	0	0	0	0	—	0
Côté droit (LAT-D)	364,8	69,6%	9	0	0	0	47	7,7	9
Érigée / Debout (STAND)	80,5	15,4%	2	0	0	0	13	9,7	2
Total / Moyenne	524,5	100%	13	0	0	0	82	10,2	13

2.2. CINÉTIQUE DE L'OXYMÉTRIE DE POULS (SpO₂)

TABLE 2 – Paramètres oxymétriques détaillés et cinétique du signal

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Norme / Référence
SpO ₂ maximale (%)	99	95 – 100 %
SpO ₂ minimale (Nadir oxymétrique ponctuel)	90	≥ 90 %
SpO ₂ moyenne (%)	95	≥ 95 %
Durée cumulée des désaturations relatives (min)	58,2	11,1 % de l'examen
Durée moyenne d'une désaturation	42,6 s	—
Durée maximale d'une désaturation	119,0 s	< 20 s
Nombre total d'événements de désaturation (DO)	82	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)	10,2 /h	< 5 /h
Index de Désaturation en Décubitus Dorsal	20,1 /h	< 5 /h
Index de Désaturation en Latéral Droit	7,7 /h	< 5 /h
Temps passé sous 95% de SpO ₂ (min)	296,0	56,5 % du temps total
Temps sous 90% de SpO ₂ (T90 en min)	0,0	0,0 % (Non significatif)
Temps passé sous 85% de SpO ₂ (min)	0,0	0,0 % du temps total
Temps passé sous 80% de SpO ₂ (min)	0,0	0,0 % du temps total

2.3. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – **Caractérisation et indexation ventilatoire**

Catégorie Événementielle	Nombre	Index (/h)
Apnées (Total : 0)		
Apnées Obstructives (SAOS)	0	
Apnées Centrales (AC)	0	
Apnées Mixtes (AM)	0	
Durée cumulée des apnées	0,0 min	(0,0% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	—	—
Hypopnées (Total : 13)		
Nombre total d'hypopnées	13	1,5
Durée cumulée des hypopnées	5,1 min	(1,0% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	23,7 s	53,6 s
Synthèse Ventilatoire Globale		
Nombre cumulé d'événements respiratoires	13	—
Durée totale cumulée sous événement (min)	5,1 min	1,0 % de l'enregistrement
Durée moyenne d'un événement respiratoire	23,7 s	—
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	—	1,5 /h
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	—	10,2 /h
Respiratory Disturbance Index (RDI)	—	1,5 /h

3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

TABLE 4 – Récapitulatif des biomarqueurs polygraphiques et cardiovasculaires

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	95 %	SpO ₂ minimale (%)	90 %
IDO global (/h)	10,2	IDO dorsal (/h)	20,1
Temps total d'enregistrement	524,5 min (8h 45)	RDI (/h)	1,5
Nombre SAOS	0	Nombre Apnées Centrales	0
Nombre Apnées Mixtes	0	Total Apnées	0
Index d'Apnées (IA /h)	0,0	Nombre d'Hypopnées	13 (IH : 1,5/h)
IAH global (/h)	1,5	Changements de position	173
Fréquence cardiaque moyenne	56,5 bpm	FC min / FC max (bpm)	45 / 90
Pression moyenne	4,8 cmH ₂ O	Pression maximale	4,9 cmH ₂ O
IMC (kg/m ²)	27,7	Durée max Apnée (s)	—
Durée max Hypopnée (s)	53,6	Durée max Désaturation (s)	119,0

4. AVIS MÉDICAL ET CONDUITE À TENIR

1. Synthèse Polygraphique

- **Index ventilatoire normal** : Absence de SAHOS selon les critères conventionnels de l'IAH (IAH = 1,5 /h ; 0 apnée, 13 hypopnées).
- **Dissociation oxymétrique** : Hématose basale normale (SpO₂ moyenne 95%, T90 nul à 0%), mais index de désaturation modérément augmenté (IDO global = 10,2 /h).
- **Composante posturale nette** : Majoration franche des événements en décubitus dorsal (IDO dorsal = 20,1 /h contre 7,7 /h en latéral droit), traduisant une collapsibilité des VAS position-dépendante.

2. Conclusion Diagnostique

- Pas d'argument pour un SAHOS obstructif franc à l'IAH.
- Profil en faveur de **limitations de débit inspiratoire posturales** (suspicion de syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures - SARVAS / RERA).

3. Conduite à Tenir & Recommandations

1. **Thérapie positionnelle** : Éviction active du décubitus dorsal (dispositif anti-dorsal / positionnement latéral exclusif).